

REVISÃO - OSCE

OBS: Antes de qualquer exame

- *Lavar mãos*
- Identificar paciente
- Explicar exame
- Pedir consentimento
- Garantir privacidade
- Posicionar paciente
- Expor apenas o necessário

1 – Exame físico geral, sinais vitais, HAS.

Sinais vitais:

FC: palpação radial por 60 s - Normal: 60–100 bpm

FR: observação do tórax por 60 s (sem avisar) - Normal: 12–20 irpm

Temperatura axilar: 36,0–36,9°C | oral: +0,5°C | retal: +1°C

SpO₂: oximetria de pulso - Normal: ≥ 95%

Glicemia capilar: jejum < 100 mg/dL

*Peso/IMC: avaliar sobrepeso (25–29,9) e obesidade (≥30)

PASSO A PASSO - Aferição da PA

Pergunte antes:

“O senhor(a) fumou, tomou café, fez exercício ou está com a bexiga cheia nos últimos 30 minutos?”

O paciente deve estar:

- Sentado, com as costas apoiadas.
- Pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas.
- Braço desnudo, sem roupa apertando.
- Braço apoiado na altura do coração.
- Paciente em repouso por cerca de 5 minutos.

A bolsa inflável do manguito deve cobrir aproximadamente:

40% da circunferência do braço em largura

80% a 100% da circunferência do braço em comprimento

No braço desnudo.

2 a 3 cm acima da fossa cubital.

Com a parte central da bolsa sobre a artéria braquial.

Palpe o pulso radial.

Insufle o manguito até o pulso desaparecer.

Anote mentalmente esse valor.

Desinsufle completamente.

Aguarde alguns segundos.

Depois, na medida auscultatória, insufla cerca de 20 a 30 mmHg acima desse valor.

Agora faça a aferição real.

Passos:

1. Palpe a artéria braquial na fossa cubital.
2. Coloque o estetoscópio sobre a artéria braquial, sem apertar demais.
3. Insufla o manguito 20 a 30 mmHg acima da sistólica estimada.
4. Desinsufla lentamente, cerca de 2 mmHg por segundo.
5. Ausculta os sons de Korotkoff.

Pressão sistólica - Valor em que aparece o primeiro som de Korotkoff.

Pressão diastólica - Valor em que ocorre o desaparecimento dos sons.

Classificação da HAS: Diretriz 2025

Quadro 3.2 – Classificação da pressão arterial de acordo com a medida no consultório a partir de 18 anos de idade

Classificação da PA	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
PA normal	< 120	e	< 80
Pré-hipertensão	120-139	e/ou	80-89
HA Estágio 1	140-159	e/ou	90-99
HA Estágio 2	160-179	e/ou	100-109
HA Estágio 3	≥ 180	e/ou	110

DBHA: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial; HA: hipertensão arterial; PA: pressão arterial; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica. "A classificação é definida de acordo com a PA no consultório e pelo nível mais elevado de PA, sistólica ou diastólica. "A HA sistólica isolada, caracterizada pela PAS ≥ 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, é classificada em Estágio 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da PAS nos intervalos indicados. "A HA diastólica isolada, caracterizada pela PAS < 140 mmHg e PAD ≥ 90 mmHg, é classificada em Estágio 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da PAD nos intervalos indicados.

O diagnóstico de HAS é confirmado por PA ≥ 140/90 mmHg em consultório, medida corretamente e repetida em pelo menos duas ocasiões diferentes, ou por MAPA/MRPA alteradas; se PA ≥ 180/110 mmHg, pode ser confirmado já na primeira consulta, após repetir a medida e excluir erro de técnica.

Exames para Investigação Inicial:

- Hemograma, glicemia, lipidograma, ácido úrico
- Creatinina + TFG
- Potássio sérico
- EAS + microalbuminúria
- Eletrocardiograma (12 derivações)
- Raio-X tórax PA (se suspeita de IC)
- Ecocardiograma (se ECG alterado ou sintomas)
- Fundoscopia (se HAS grave ou DM)

2 – Insuficiência Cardíaca

Na insuficiência cardíaca, os sintomas devem ser organizados em três grupos:

Congestão pulmonar: dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, tosse noturna e intolerância ao exercício.

Congestão sistêmica: edema de membros inferiores, ganho de peso recente, aumento do volume abdominal por ascite, desconforto em hipocôndrio direito e noctúria.

Baixo débito cardíaco: fadiga, fraqueza, tontura, confusão mental, extremidades frias e redução da diurese.

Achados no exame físico:

No exame físico, deve-se avaliar sinais de congestão pulmonar, congestão sistêmica e baixo débito.

Na congestão pulmonar, os principais achados são estertores crepitantes bibasais, taquipneia, hipoxemia, sibilos e redução do murmúrio vesicular em bases, quando há derrame pleural.

Na congestão sistêmica, devem ser pesquisados turgência jugular, refluxo hepatojugular positivo, hepatomegalia dolorosa, ascite e edema de membros inferiores com cacifo.

Na avaliação cardíaca, podem ser encontrados terceira bulha, quarta bulha, sopros, ritmo irregular e ictus cordis desviado ou difuso.

No baixo débito, observam-se extremidades frias, sudorese, pulso fino, hipotensão, tempo de enchimento capilar prolongado, oligúria e alteração do nível de consciência.

Testes e manobras semiológicas

A turgência jugular deve ser avaliada com o paciente a 30–45 graus. Quando elevada, sugere aumento da pressão venosa central e congestão sistêmica.

O refluxo hepatojugular é pesquisado com compressão firme e contínua do hipocôndrio direito ou abdome superior por 10 a 30 segundos, observando a jugular. É positivo quando há elevação sustentada da turgência jugular, sugerindo insuficiência cardíaca direita.

O edema deve ser avaliado por digitopressão em região pré-tibial, maléolos ou dorso dos pés. A presença de cacifo indica edema depressível, geralmente associado à retenção hídrica.

A terceira bulha deve ser pesquisada no foco mitral, preferencialmente com a campânula e o paciente em decúbito lateral esquerdo. Sua presença sugere sobrecarga de volume e é um achado importante na insuficiência cardíaca.

O ictus cordis deve ser palpado no precórdio. Quando desviado para baixo e para a esquerda, ou difuso, sugere cardiomegalia ou dilatação ventricular.

Exames complementares

Na radiografia de tórax, podem ser observados cardiomegalia, cefalização da trama vascular, linhas B de Kerley, edema alveolar peri-hilar em “asa de borboleta” e derrame pleural.

No eletrocardiograma, devem ser procurados sinais de hipertrofia ventricular esquerda, fibrilação atrial, bloqueio de ramo, isquemia ou infarto prévio.

O ecocardiograma é essencial para avaliar fração de ejeção, função sistólica e diastólica, câmaras cardíacas, hipertrofia, valvopatias e alterações segmentares.

O BNP ou NT-proBNP auxilia quando há dúvida diagnóstica: se elevado, favorece insuficiência cardíaca; se baixo, torna o diagnóstico menos provável.

Exames laboratoriais úteis incluem hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, glicemia/HbA1c, perfil lipídico, TSH e troponina, quando houver suspeita de síndrome coronariana.

3 – Coronariopatias

Nas coronariopatias, o principal sintoma é a dor torácica anginosa, geralmente descrita como dor ou desconforto em aperto, peso, pressão ou queimação, localizada em região retroesternal ou precordial, podendo irradiar para braço esquerdo, ombro, mandíbula, dorso ou epigástrico.

Angina Estável:

- Dor/desconforto retroesternal em aperto ou pressão
- Irradiação: MSE, mandíbula, epigástrico
- Duração: 2–10 min; alivia com repouso ou nitrato
- Precipitada por esforço, emoção, frio
- Classificação CCS (I–IV) conforme limiar de esforço

SCA (Síndrome Coronariana Aguda)

- Angina Instável: angina em repouso, de início recente ou em crescendo SEM elevação de troponina
- IAMSSST: angina em repouso + troponina elevada, SEM supradesnívelamento de ST
- IAMCSST: dor prolongada > 20 min + supradesnívelamento de ST ≥ 1 mm (2 mm em V1–V3) + troponina elevada
- Apresentação atípica (mulheres, idosos, DM): epigastralgia, náusea, fadiga, dispneia isolada

Devem ser avaliados sinais vitais, perfusão periférica, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar e sinais de complicações. Podem ser encontrados taquicardia, bradicardia, hipertensão, hipotensão, sudorese, palidez, extremidades frias e má perfusão periférica. Hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, extremidades frias e oligúria sugerem instabilidade hemodinâmica.

➤ Exames complementares e interpretação

Eletrocardiograma

O ECG de 12 derivações deve ser realizado em até 10 minutos em contexto de dor torácica aguda. A diretriz brasileira de dor torácica destaca que um único ECG inicial pode não detectar todos os casos, sendo necessário repetir o exame se a suspeita persistir.

No ECG, devem ser procurados:

Supradesnívelamento do segmento ST: sugere IAM com supra de ST e oclusão coronariana aguda.

Infradesnívelamento do segmento ST: sugere isquemia subendocárdica, comum em angina instável ou IAM sem supra.

Inversão de onda T: pode sugerir isquemia.

Onda Q patológica: pode indicar infarto prévio ou necrose miocárdica.

Arritmias e bloqueios: podem ocorrer como complicação ou fator associado.

Troponina

A troponina é o principal marcador de lesão miocárdica. Deve ser interpretada de forma seriada, observando elevação e/ou queda dos valores. Troponina elevada, associada a quadro clínico e/ou alterações no ECG, favorece diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A diretriz brasileira de SCA sem supra reforça a importância da troponina no diagnóstico e na estratificação de risco.

De forma prática:

Troponina normal: não exclui IAM se coletada muito cedo; deve ser repetida se houver suspeita.

Troponina elevada: indica lesão miocárdica, devendo ser correlacionada com clínica e ECG.

Angina instável: sintomas isquêmicos sem elevação de troponina.

IAM sem supra: sintomas isquêmicos com troponina elevada, sem supra persistente de ST.

IAM com supra: sintomas isquêmicos com supra de ST no ECG, geralmente com elevação posterior de troponina.

Como realizar o ECG no OSCE

- Preparação inicial

Antes de posicionar os eletrodos, deve-se higienizar as mãos, apresentar-se, confirmar a identificação do paciente, explicar o exame e pedir consentimento.

Em seguida, deve-se garantir privacidade, expor apenas o necessário e posicionar o paciente em decúbito dorsal, relaxado, sem falar e sem cruzar braços ou pernas.

Também é importante preparar a pele, limpando suor ou oleosidade e afastando pelos se prejudicarem a aderência dos eletrodos.

- Posicionamento dos eletrodos periféricos

Os eletrodos periféricos podem ser colocados nos punhos e tornozelos ou em regiões mais proximais dos membros, desde que de forma simétrica.

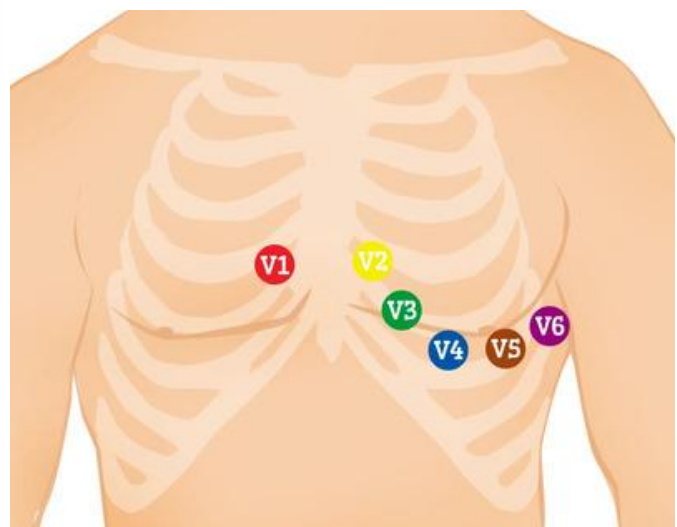
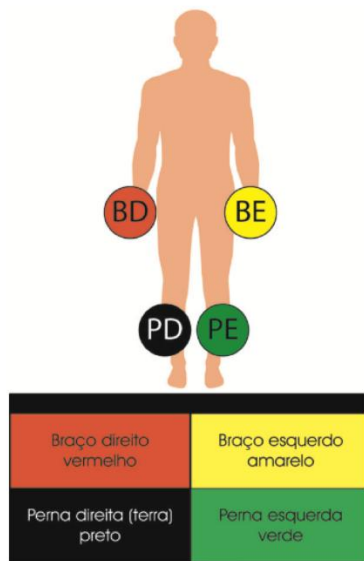
A ordem clássica é:

Braço direito: vermelho

Braço esquerdo: amarelo

Perna esquerda: verde

Perna direita: preto / neutro



V1 - 4º espaço intercostal direito, junto à borda esternal direita.

V2 - 4º espaço intercostal esquerdo, junto à borda esternal esquerda.

V3 - Entre V2 e V4.

V4 - 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular esquerda.

V5 - Na mesma linha horizontal de V4, na linha axilar anterior esquerda.

V6 - Na mesma linha horizontal de V4 e V5, na linha axilar média esquerda.

4 – Valvulopatias

Estenose Mitral (EM)

- Etiologia: sequela reumática (principal)
- Sopro: ruflar diastólico em foco mitral (rumble), melhor com decúbito lateral esquerdo e sino do estetoscópio
- B1 hiperfonética + estalido de abertura mitral
- Fácies mitralica: cianose malar bilateral
- Complicações: FA, hipertensão pulmonar, embolias sistêmicas
- Pulso: parvus (débito reduzido)
- Sinais de HP: B2 hiperfonética em foco pulmonar

Insuficiência Mitral (IM)

- Etiologia: prolapso da valva mitral (mais comum no mundo), reumática, isquêmica
- Sopro: holossistólico em foco mitral com irradiação para axila
- Característica: não altera com a respiração
- B3 (regurgitação volumosa)
- Achados de IC no exame (dispneia, crepitações, TVJ)
- Prolapso mitral: click mesossistólico + sopro telediastólico; piora em posição ortostática

Estenose Aórtica (EA)

- Tríade clássica: síncope, angina, dispneia
- Sopro: ejetivo mesossistólico (crescendodecrescendo) no foco aórtico (2º EIC para-esternal D), com irradiação para carótidas
- Pulso parvus et tardus (pequeno amplitude e ascenso lento)
- B2 hipofonética ou abolida (imobilidade da valva)
- Frêmito sistólico em foco aórtico
- Apex deslocado (HVE excêntrica na EA grave)

Insuficiência Aórtica (IA)

- Etiologia: febre reumática, bicúspide, endocardite, aortite sífilítica
- Sopro: diastólico em decrescendo em foco aórtico acessório (3º EIC para-esternal E), melhor com paciente sentado inclinado à frente
- Pulso em martelo d'água (Corrigan): ascenso rápido e colapso súbito
- Pressão de pulso alargada (PAS elevada, PAD baixa)
- Sinal de Musset: movimento de balanceio da cabeça
- Sinal de Quincke: pulsação capilar nas unhas
- Sinal de Duroziez: sopro bidirecional à compressão da femoral

5 – DAOP

- O sintoma mais típico é a claudicação intermitente, caracterizada por dor, câimbra, peso ou fadiga muscular durante a marcha, que melhora com repouso.
- A dor costuma acometer principalmente a panturrilha, mas pode ocorrer em coxa ou região glútea, dependendo do nível da obstrução arterial. Quanto menor a distância percorrida até surgir a dor, maior a limitação funcional.
- Em casos mais graves, podem surgir dor em repouso, principalmente à noite ou com o membro elevado, além de feridas de difícil cicatrização, úlceras, necrose ou gangrena. Esses achados sugerem isquemia crítica ou ameaça ao membro.

❖ Achados no exame físico

-A avaliação deve ser comparativa entre os membros inferiores, observando coloração, temperatura, trofismo da pele, pulsos periféricos, enchimento capilar e presença de lesões.

Os principais achados são pulsos periféricos reduzidos ou ausentes, especialmente femoral, poplíteo, tibial posterior e pedioso. A palpação dos pulsos pode mostrar redução ou ausência no membro afetado.

Também podem aparecer extremidade fria, palidez à elevação, rubor em posição pendente, pele fina e brilhante, redução de pelos, unhas distróficas, atrofia muscular, enchimento capilar lentificado, úlceras isquêmicas e áreas de necrose.

As úlceras arteriais costumam ser dolorosas, com bordas bem definidas, fundo pálido ou necrótico, localizadas principalmente em dedos, dorso do pé, calcâneo ou áreas de pressão.

Na ausculta vascular, pode haver sopro femoral, sugerindo estenose arterial.



Palpação da artéria femoral



Palpação da artéria poplíteia



Palpação da artéria poplíteia



Palpação da artéria tibial posterior



Palpação da artéria tibial anterior



Palpação da artéria dorsal do pé

Pulso Femoral: Palpado na virilha (trígono femoral), logo abaixo do ligamento inguinal, no ponto médio entre o osso do quadril e o osso púbico.

Pulso Poplíteo: Avaliado na parte de trás do joelho (fossa poplíteia). Exige que o joelho do paciente fique levemente flexionado, com o avaliador aprofundando os dedos no centro da cavidade.

Pulso Tibial Posterior: Palpado logo abaixo e atrás do maléolo medial (a parte mais saliente do "osso do tornozelo" na face interna).

Pulso Tibial Anterior: Palpado na parte da frente do tornozelo, no espaço entre os tendões dos músculos tibial anterior e extensor longo do hálux, logo antes de se tornar o pulso pedioso.

Pulso Pedioso (Dorsal do Pé): Localizado no dorso do pé, geralmente no primeiro espaço intermetatarsal (entre o dedão e o segundo dedo), usando uma pressão leve.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO RUTHERFORD	
Estágio 0	Assintomático
Estágio 1	Claudicação leve
Estágio 2	Claudicação moderada
Estágio 3	Claudicação grave
Estágio 4	Dor em repouso
Estágio 5	Úlcera isquêmica
Estágio 6	Úlcera isquêmica grave ou gangrena

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FONTAINE	
Estágio 1	Assintomático
Estágio 2	2a: Claudicação a distância >200m
	2b: Claudicação a distância < 200m
Estágio 3	Dor noturna e/ou em repouso
Estágio 4	Úlcera isquêmica e/ou gangrena

- Índice Tornozelo-Braquial (ITB)

Material necessário: doppler vascular portátil + esfigmomanômetro

Passo 1: Paciente em decúbito dorsal por 10 min

Passo 2: Medir PA sistólica no braço direito e esquerdo com doppler sobre a artéria braquial

Passo 3: Medir PA sistólica no tornozelo (artéria tibial posterior e pediosa dorsal) bilateralmente

Cálculo: $ITB = \text{maior PAS tornozelo} \div \text{maior PAS braquial}$

ITB > 1,3: calcificação arterial (DM, DRC) — não diagnóstico

ITB 1,0–1,3: normal

ITB 0,9–1,0: limítrofe

ITB 0,7–0,9: DAOP leve

ITB 0,4–0,7: DAOP moderada

ITB < 0,4: DAOP grave / isquemia crítica

- Exames complementares: duplex scan, angiotomografia, arteriografia

6 – TVP e Insuficiência venosa

- Sintomas TVP

Na TVP, os sintomas geralmente acometem um dos membros inferiores.

- Os principais sintomas são dor em panturrilha ou membro inferior, sensação de peso, edema unilateral, aumento da temperatura local, vermelhidão e empastamento da panturrilha.

A dor pode piorar à marcha ou à palpação da panturrilha. O edema assimétrico é um achado importante, principalmente quando há diferença de circunferência entre os membros.

Fatores de risco que devem ser valorizados no caso clínico incluem imobilização prolongada, cirurgia recente, internação, câncer, gestação/puerpério, uso de anticoncepcional ou terapia hormonal, trombofilia, obesidade, tabagismo e história prévia de TEV.

No exame físico, deve-se comparar os dois membros inferiores.

- Os principais achados são edema unilateral, dor à palpação da panturrilha, aumento de temperatura local, eritema, empastamento muscular, veias superficiais dilatadas e diferença de circunferência entre as pernas.

A circunferência da panturrilha pode ser medida em pontos simétricos nos dois membros. Diferença maior que **3 cm** favorece suspeita clínica de TVP, especialmente quando associada a dor e edema.

Apesar de serem achados sugestivos, o exame físico isolado não confirma TVP; geralmente é necessário exame de imagem, sendo o ultrassom vascular com Doppler o método não invasivo mais usado para confirmação.

- Sinais:

- Sinal de Homans



É pesquisado com o paciente em decúbito dorsal, joelho estendido ou levemente fletido. O examinador realiza dorsiflexão passiva do pé.

O sinal é considerado positivo quando essa manobra provoca dor na panturrilha.

- Sinal de Bancroft



É pesquisado comprimindo a panturrilha do paciente.

O examinador realiza compressão da panturrilha no sentido anteroposterior, pressionando contra a tíbia, e compara com a compressão lateral.

O sinal é considerado positivo quando há dor à compressão anteroposterior da panturrilha, mais intensa do que à compressão lateral.

- Sinal da Bandeira



É avaliado com o paciente em decúbito dorsal, comparando as duas panturrilhas.

O examinador mobiliza a panturrilha no sentido lateral, observando sua mobilidade.

O sinal é considerado positivo quando há menor mobilidade da panturrilha acometida, como se ela estivesse mais rígida ou “presa”, em comparação ao lado contralateral.

- Sintomas sugestivos de TEP

No tromboembolismo pulmonar, os principais sintomas são dispneia súbita, dor torácica pleurítica, taquipneia, taquicardia, tosse, hemoptise, síncope, tontura e sensação de ansiedade ou morte iminente.

Casos graves podem evoluir com hipotensão, cianose, choque, rebaixamento do nível de consciência e parada cardiorrespiratória.

- Achados no exame físico do TEP

Os achados mais comuns são taquipneia, taquicardia, queda da saturação de oxigênio, dor torácica ventilatório-dependente e sinais de esforço respiratório.

Em casos mais graves, podem aparecer hipotensão, turgência jugular, cianose, extremidades frias e sinais de choque obstrutivo.

Também devem ser procurados sinais de TVP em membros inferiores, como edema unilateral, dor em panturrilha, empastamento e aumento da temperatura local.

- Exames complementares

- D-dímero

O D-dímero é útil principalmente quando a probabilidade clínica é baixa ou intermediária. Se vier negativo nesse contexto, ajuda a excluir TEV.

- Ultrassom venoso com Doppler

É o principal exame para confirmar TVP em membros inferiores. Avalia a presença de trombo, compressibilidade da veia e fluxo venoso. A ausência de compressibilidade venosa é um achado sugestivo de trombose.

- Angiotomografia de artérias pulmonares

É o exame de escolha mais usado para confirmar TEP em paciente estável, demonstrando falhas de enchimento nas artérias pulmonares.

- Cintilografia de ventilação/perfusão

Pode ser alternativa quando há contraindicação à angiotomografia, como alergia a contraste ou algumas situações de disfunção renal.

- Sintomas Insuficiência Venosa

Os sintomas mais comuns são peso nas pernas, dor em queimação ou cansaço, edema vespertino, prurido, câimbras, sensação de calor, piora com ortostatismo prolongado e melhora com elevação dos membros.

Também podem ocorrer varizes visíveis e sensação de inchaço ao final do dia. Na doença venosa crônica, edema, dermatite, alterações de pele e ulceração podem fazer parte do quadro.

- Achados no exame físico da insuficiência venosa

No exame físico, devem ser procurados varizes, edema de membros inferiores, hiperpigmentação acastanhada, dermatite ocre, eczema venoso, lipodermatoesclerose, atrofia branca e úlcera venosa.

A úlcera venosa costuma localizar-se na região maleolar, principalmente próxima ao maléolo medial, geralmente com bordas irregulares, fundo úmido/granuloso e exsudato variável. Costuma estar associada a edema, varizes e alterações cutâneas crônicas.

Score de Wells para TVP	Insuficiência Venosa — Classificação CEAP
• +1 Neoplasia ativa • +1 Paralisia ou imobilização de MMII • +1 Acamado $\geq$ 3 dias OU cirurgia nas últimas 12 sem. • +1 Dor em trajeto venoso profundo • +1 Edema unilateral de toda a perna • +1 Edema da panturrilha $\geq$ 3 cm vs contralateral • +1 Edema depressível restrito à perna sintomática • +1 Veias superficiais colaterais (não varicosas) • -2 Diagnóstico alternativo tão ou mais provável • $\geq$ 2: alta probabilidade 1: moderada $\leq$ 0: baixa	• C0: Sem sinais visíveis ou palpáveis • C1: Telangiectasias ou veias reticulares • C2: Varizes ($>$ 3 mm de diâmetro) • C3: Edema • C4a: Alterações cutâneas (eczema, hiperpigmentação) • C4b: Lipodermatoesclerose, atrofia branca • C5: Úlcera cicatrizada • C6: Úlcera venosa ativa • Úlcera venosa: medial, bordas irregulares, fundo com granulação, dor leve, edema associado

7 – Tuberculose Pulmonar e extrapulmonar

Tosse ≥ 3 semanas (principal sintoma — sintomático respiratório)

Hemoptise (de estrias a franca)

Síndrome constitucional: febre vespertina, sudorese noturna, perda ponderal ($> 10\%$ do peso)

Dispneia: formas extensas ou pleurite associada

- O exame físico pode ser pobre ou até normal, principalmente no início.

Podem aparecer estado geral comprometido, emagrecimento, febre, taquicardia, palidez, linfonodomegalias e sinais respiratórios.

Os achados respiratórios variam conforme a extensão da doença.

Na inspeção, deve-se observar o padrão respiratório e sinais gerais de comprometimento pulmonar.

Podem estar presentes:

Na inspeção: Taquipneia, dispneia, uso de musculatura acessória, assimetria da expansibilidade torácica

Pode ocorrer quando há derrame pleural, atelectasia ou acometimento importante de um hemitórax, emagrecimento e aspecto consumptivo.

Na palpação, os principais pontos são expansibilidade torácica e frêmito toracovocal.

-- Expansibilidade torácica

Na TB, pode haver:

Expansibilidade preservada, em casos leves.

Expansibilidade reduzida unilateralmente, se houver derrame pleural, dor pleurítica, atelectasia ou lesão extensa em um lado.

-- Frêmito toracovocal

Na TB, o frêmito pode variar:

Aumentado

Quando há consolidação pulmonar, porque o som se transmite melhor em tecido pulmonar preenchido por material inflamatório.

Diminuído ou abolido

Quando há derrame pleural, pneumotórax ou barreira entre pulmão e parede torácica.

Normal

Em lesões pequenas ou profundas.

Na percussão, o objetivo é identificar se o som pulmonar está normal, maciço ou hipersonoro.

Som claro pulmonar - achado normal.

Pode estar presente em TB inicial ou lesões pequenas.

Submacicez ou macicez

Pode ocorrer em:

Consolidação pulmonar

Área inflamada e preenchida por exsudato.

Derrame pleural

Líquido no espaço pleural.

Na TB pleural, a macicez costuma ser mais evidente nas bases.

Hipersonoridade

Não é o achado mais típico da TB, mas pode aparecer se houver grandes cavitações ou hiperinsuflação associada.

-- A ausculta pode ser normal ou apresentar alterações conforme a forma da doença.

Murmúrio vesicular reduzido

Pode ocorrer em:

Derrame pleural

Atelectasia

Lesões extensas

Espessamento pleural

Na TB pleural, é comum haver redução ou abolição do murmúrio vesicular na região do derrame.

-Estertores crepitantes

Podem aparecer em áreas de inflamação ou consolidação.

-Roncos

Podem ocorrer se houver secreção em vias aéreas maiores.

-Sopro tubário*

Pode ocorrer quando há consolidação pulmonar com brônquio pérvio.

É um som respiratório mais intenso, rude, semelhante ao som ouvido sobre a traqueia, mas auscultado no campo pulmonar.

-Atrito pleural

Pode ocorrer quando há acometimento pleural.

É um som áspero, semelhante a “couro rangendo”, geralmente associado à dor pleurítica.

Pode aparecer na tuberculose pleural, principalmente antes de haver grande derrame.

- Exames complementares e interpretação

Teste rápido molecular para tuberculose — TRM-TB

O TRM-TB é um dos principais exames para diagnóstico inicial. Ele detecta o DNA do *Mycobacterium tuberculosis* e também pode identificar resistência à rifampicina. Segundo o Ministério da Saúde, é método de escolha para identificar casos novos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, com resultado rápido.

Na TB pulmonar, é feito preferencialmente em amostra de escarro. Na TB extrapulmonar, pode ser realizado no material do sítio acometido, como líquido pleural, líquido, aspirado de linfonodo ou biópsia, dependendo da forma clínica.

- Baciloscopia de escarro

A baciloscopia pesquisa bacilos álcool-ácido resistentes no escarro.

É útil principalmente na TB pulmonar bacilífera, que tem maior potencial de transmissão. Porém, pode ser negativa mesmo em pacientes com tuberculose, especialmente em formas paucibacilares, extrapulmonares ou em pessoas vivendo com HIV.

- Cultura para micobactéria

A cultura é mais sensível que a baciloscopia e permite identificação do microrganismo e realização de teste de sensibilidade aos medicamentos.

É importante em casos de suspeita clínica com exames iniciais negativos, retratamento, suspeita de resistência, formas extrapulmonares e populações de maior risco.

- Radiografia de tórax

Na TB pulmonar, a radiografia pode mostrar:

Infiltrados em lobos superiores

Cavitações

Nódulos

Fibrose ou retração

Derrame pleural

Padrão miliar, com múltiplos micronódulos difusos

A cavitação em ápices é um achado clássico da tuberculose pós-primária.



Na TB pleural, pode haver derrame pleural, geralmente unilateral.

- Tomografia de tórax

A tomografia pode ser útil quando a radiografia é duvidosa, em casos de complicações, suspeita de TB miliar, imunossuprimidos ou avaliação mais detalhada de lesões pulmonares.

Pode mostrar cavitações, árvore em brotamento, nódulos centrolobulares, consolidações, linfonodomegalias e padrão miliar.

- Prova tuberculínica e IGRA

A prova tuberculínica e o IGRA indicam infecção pelo *M. tuberculosis*, mas não diferenciam tuberculose latente de doença ativa.

São mais úteis na investigação de infecção latente e avaliação de contatos, não sendo suficientes para confirmar TB ativa sozinhos.

8 – DPOC

A doença pulmonar obstrutiva crônica deve ser suspeitada em pacientes com sintomas respiratórios persistentes e exposição a fatores de risco, principalmente tabagismo, fumaça de biomassa, poeiras ou gases ocupacionais.

- Os sintomas principais são dispneia progressiva, tosse crônica e expectoração crônica. A dispneia costuma piorar aos esforços e evoluir lentamente ao longo dos anos. A tosse pode ser diária ou intermitente, geralmente associada à produção de escarro.

- Também podem ocorrer sibilância, aperto torácico, infecções respiratórias recorrentes, intolerância ao exercício, fadiga e perda de peso em casos avançados.

- Nas exacerbações, há piora aguda da dispneia, aumento do volume do escarro e/ou mudança da coloração da secreção, podendo haver febre, chiado, queda da saturação e sinais de esforço respiratório.

Fenótipos Clínicos

Pink Puffer (Enfisematoso): magro, dispneico grave, tosse escassa, tórax em tonel, hiperfonese, uso de musculatura acessória, respira com lábios franzidos

Blue Bloater (Bronquítico crônico): obeso/sobrepeso, cianose, tosse produtiva ≥ 3 meses/ano por ≥ 2 anos consecutivos, sibilos, edemas — hipoxemia crônica

Exame físico: hiperinsuflação, redução do murmúrio vesicular, prolongamento do tempo expiratório, roncos e sibilo.

- Espirometria

A espirometria é o principal exame para confirmar DPOC. O diagnóstico exige quadro clínico compatível e obstrução persistente ao fluxo aéreo.

O critério clássico é:

VEF_1/CVF pós-broncodilatador $< 0,70$.

Esse achado confirma limitação persistente ao fluxo aéreo, compatível com DPOC quando associado ao contexto clínico adequado. A GOLD 2026 mantém a espirometria como essencial para diagnóstico, com confirmação por VEF_1/CVF pós-broncodilatador menor que 0,70.

Classificação GOLD (Espirometria)

- Critério: $VEF_1/CVF < 0,70$ pós-broncodilatador
- GOLD 1 (Leve): $VEF_1 \geq 80\%$ do predito
- GOLD 2 (Moderada): $VEF_1 50-79\%$
- GOLD 3 (Grave): $VEF_1 30-49\%$
- GOLD 4 (Muito grave): $VEF_1 < 30\%$
- mMRC (dispneia) + CAT Score + exacerbações → grupos A, B, E
- FRC: tabagismo (principal), exposição ocupacional, biomassa

A manobra básica é a capacidade vital forçada.

O passo a passo é:

1. O paciente respira normalmente.
2. Inspira profundamente até encher completamente os pulmões.
3. Coloca o bocal na boca, vedando bem com os lábios.
4. Sopra o mais forte, rápido e prolongado possível.

5. Continua soprando até não sair mais ar.
6. Depois pode ser orientado a inspirar novamente, conforme o aparelho.

Devem ser feitas pelo menos 3 manobras aceitáveis.

O exame só é considerado confiável quando há boa técnica e reprodutibilidade entre as curvas.

A espirometria antes e depois do broncodilatador.

Passos:

1. Realiza-se a espirometria basal.
2. Administra-se broncodilatador inalatório, geralmente salbutamol.
3. Aguarda-se cerca de 10 a 15 minutos.
4. Repete-se a espirometria.

9 – Síndromes Pleurais

- Derrame pleural

Ocorre acúmulo de líquido no espaço pleural. Pode causar dispneia, dor torácica pleurítica, tosse seca e redução da expansibilidade do lado acometido. Alguns derrames podem ser assintomáticos e achados apenas no exame físico ou radiografia.

No exame físico, o padrão clássico é:

Inspeção: expansibilidade reduzida no lado acometido.

Palpação: frêmito toracovocal diminuído ou abolido.

Percussão: macicez.

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído ou abolido.

Na radiografia, pode aparecer velamento do seio costofrênico, opacidade basal e sinal do menisco. Derrames maiores podem causar desvio do mediastino para o lado oposto.

OBS: Lembrar que o derrame pleural muitas vezes é a consequência de uma patologia base.

- Pneumotórax

Ocorre presença de ar no espaço pleural. Pode causar dor torácica súbita, dispneia, taquipneia e redução da expansibilidade do lado acometido.

No exame físico, o padrão clássico é:

Inspeção: expansibilidade reduzida unilateralmente.

Palpação: frêmito toracovocal diminuído ou abolido.

Percussão: hipertimpanismo ou hipersonoridade.

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído ou abolido.

Na radiografia, pode aparecer linha pleural visível e ausência de trama vascular periférica. No pneumotórax hipertensivo, pode haver desvio do mediastino para o lado oposto e instabilidade clínica.

- Pleurite

É inflamação da pleura. O sintoma mais característico é a dor torácica pleurítica, que piora com inspiração profunda, tosse ou movimento respiratório.

No exame físico, pode haver:

Inspeção: respiração superficial por dor.

Palpação: expansibilidade reduzida por limitação dolorosa.

Percussão: geralmente normal, se não houver derrame associado.

Ausculta: atrito pleural.

O atrito pleural é um som áspero, semelhante a “couro rangendo”, mais audível durante a inspiração e expiração.

- Hemotórax

Acúmulo de sangue no espaço pleural, geralmente por trauma torácico, procedimento invasivo, neoplasia ou ruptura vascular.

Sintomas: dor torácica, dispneia, palidez, sudorese, taquicardia e hipotensão se houver grande perda sanguínea.

Inspeção: expansibilidade reduzida no lado acometido.

Palpação: frêmito toracovocal diminuído ou abolido.

Percussão: macicez.

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído ou abolido.

RX: opacidade/velamento pleural, semelhante a derrame.

Diferença importante: no hemotórax, pode haver sinais de choque hipovolêmico.

Empiema pleural

Acúmulo de pus no espaço pleural, geralmente complicação de pneumonia.

Sintomas: febre, calafrios, dor torácica pleurítica, tosse, dispneia e toxemia.

Inspeção: expansibilidade reduzida.

Palpação: frêmito toracovocal diminuído.

Percussão: macicez.

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído.

RX/USG: derrame pleural, muitas vezes loculado.

Pense em empiema quando houver derrame + quadro infeccioso importante.

- Características do Líquido Pleural

Transudato: ICC, cirrose, síndrome nefrótica | Proteínas < 3g/dL; LDH < 200 UI/L

Exsudato: Critérios de Light (basta 1): LP proteína/S proteína > 0,5; LP LDH/S LDH > 0,6; LP LDH > 2/3 LSN sérico

Exsudato: infecção, neoplasia, TB, colagenoses

Hemotórax: LP/S hematócrito > 0,5

Quilotórax: LP triglicerídeos > 110 mg/dL

Empiema: pus macroscópico; pH < 7,2; glicose < 60; bactérias ao Gram

10 – Síndromes Brônquicas e Pulmonares

- Principais síndromes brônquicas

- Bronquite aguda

Geralmente infecciosa, de curta duração.

Sintomas: tosse, expectoração, desconforto torácico, febre baixa, mal-estar.

Exame físico: roncosp, sibilos esparsos e ausculta muitas vezes normal.

Ponto-chave: quadro agudo, geralmente pós-viral.

- Bronquite crônica

Definida clinicamente por tosse produtiva crônica.

Crítério clássico: tosse com expectoração por pelo menos 3 meses em 2 anos consecutivos.

Sintomas: tosse produtiva persistente, expectoração crônica, dispneia progressiva.

Exame físico: roncosp, sibilos, expiração prolongada e, em casos avançados, sinais de DPOC.

- Asma

Doença obstrutiva variável e reversível.

Sintomas: dispneia episódica, chiado, tosse, aperto no peito, piora à noite ou madrugada, desencadeada por alérgenos, exercício, frio ou infecções.

Exame físico: sibilos difusos, expiração prolongada, uso de musculatura acessória em crises.

Gravidade: tórax silencioso, cianose, fala entrecortada, rebaixamento ou exaustão são sinais de alerta.

- DPOC

Doença obstrutiva crônica, geralmente associada ao tabagismo.

Sintomas: dispneia progressiva, tosse crônica e expectoração.

Exame físico: tórax em tonel, expansibilidade reduzida, hipersonoridade, murmúrio vesicular reduzido, sibilos, roncosp e expiração prolongada.

- Bronquiectasias

Dilatação anormal e permanente dos brônquios.

Sintomas: tosse crônica com grande quantidade de expectoração, geralmente purulenta, infecções respiratórias recorrentes, hemoptise e dispneia.

Exame físico: roncosp, estertores grossos, sibilos e, em casos crônicos, baqueteamento digital.

- Síndromes Pulmonares

- Síndrome de consolidação pulmonar

Ocorre quando o ar dos alvéolos é substituído por exsudato, sangue, células ou líquido inflamatório. É clássica da pneumonia.

Sintomas

Febre, tosse, expectoração, dor torácica pleurítica, dispneia e queda do estado geral.

Exame físico

Inspeção: expansibilidade reduzida no lado acometido.

Palpação: frêmito toracovocal aumentado.

Percussão: submacicez ou macicez.

Ausculta: murmúrio vesicular reduzido, estertores crepitantes, sopro tubário, broncofonia, pectorilóquia e egofonia.

Exames

No RX, pode haver opacidade/consolidação alveolar, geralmente segmentar ou lobar, com possível broncograma aéreo.

2. Síndrome atelectásica

Ocorre por colapso de parte do pulmão, com perda de volume pulmonar. Pode ocorrer por obstrução brônquica, compressão extrínseca ou pós-operatório.

Sintomas

Dispneia, tosse seca, desconforto torácico e, se extensa, hipoxemia.

Exame físico

Inspeção: expansibilidade reduzida no lado acometido.

Palpação: frêmito toracovocal diminuído ou abolido.

Percussão: submacicez ou macicez.

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído ou abolido.

Exames

No RX, pode haver opacidade com sinais de perda de volume, como elevação do diafragma, desvio de fissuras, aproximação das costelas e desvio do mediastino para o lado acometido.

3. Síndrome cavitária

Ocorre quando há formação de cavidade no parênquima pulmonar. Pode estar associada a tuberculose, abscesso pulmonar, neoplasia escavada ou infecção necrosante.

Sintomas

Tosse crônica, expectoração, febre, sudorese noturna, perda de peso, hemoptise e dor torácica.

Exame físico

O exame pode ser pobre se a cavidade for pequena ou profunda.

Quando a cavidade é grande e comunicante com brônquio, pode haver:

Inspeção: expansibilidade reduzida localmente.

Palpação: frêmito toracovocal aumentado.

Percussão: som timpânico ou submacicez ao redor.

Ausculta: sopro anfórico, estertores localizados e pectorilóquia.

Exames

No RX ou TC, observa-se cavidade pulmonar, podendo ter parede espessa, nível hidroaéreo ou lesões em ápices, dependendo da causa.

4. Síndrome intersticial

Ocorre por acometimento do interstício pulmonar, como em fibrose pulmonar, pneumoconioses, doenças autoimunes ou algumas infecções.

Sintomas

Dispneia progressiva aos esforços, tosse seca, fadiga e intolerância ao exercício.

Exame físico

Inspeção: taquipneia e, em casos avançados, cianose.

Palpação: expansibilidade geralmente reduzida bilateralmente.

Percussão: geralmente normal.

Ausculta: estertores finos, secos, inspiratórios, tipo “velcro”, principalmente em bases.

Extremidades: pode haver baqueteamento digital em doenças crônicas.

Exames

No RX, pode haver padrão reticular, reticulonodular ou redução dos volumes pulmonares. Na TC de alta resolução, podem aparecer vidro fosco, reticulações, bronquiectasias de tração e faveolamento.

11- Anemia

A anemia deve ser suspeitada quando há redução da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Os sintomas dependem da intensidade, velocidade de instalação e comorbidades do paciente.

Os principais sintomas são fadiga, fraqueza, tontura, dispneia aos esforços, palpitações, cefaleia, sonolência, dificuldade de concentração e intolerância ao exercício. Em anemias mais graves, podem ocorrer dor torácica, síncope, taquicardia importante, hipotensão e sinais de insuficiência cardíaca.

Na anemia ferropriva, podem aparecer sintomas como pica, que é vontade de ingerir substâncias não alimentares, como gelo, terra ou amido, além de queda de cabelo e unhas frágeis. O Ministério da Saúde destaca cansaço, palidez de pele e mucosas, menor disposição e apatia como manifestações frequentes da anemia por deficiência de ferro.

- Achados no exame físico

No exame físico, o principal achado é a palidez cutaneomucosa.

Deve-se avaliar:

Conjuntiva palpebral: palidez sugere anemia.

Mucosa oral e gengivas: podem estar hipocoradas.

Palmas das mãos e pregas palmares: podem estar pálidas.

Leito ungueal: pode apresentar palidez.

Também podem ser encontrados taquicardia, pulso amplo, sopro sistólico funcional, dispneia, hipotensão postural e sinais de insuficiência cardíaca em anemias graves.

Na anemia ferropriva, podem aparecer unhas frágeis, coiloniquia, que é unha em formato de colher, queilite angular, glossite e queda de cabelo.

Na anemia megaloblástica, podem aparecer glossite, língua lisa e avermelhada, parestesias, alteração da marcha e perda de sensibilidade vibratória/proprioceptiva, especialmente por deficiência de vitamina B12.

Na anemia hemolítica, podem aparecer icterícia, esplenomegalia, urina escura e sinais de hemólise.

- Exames e interpretação

O principal exame inicial é o hemograma completo, que confirma anemia pela redução da hemoglobina e ajuda a classificar pelo VCM.

De forma prática:

Anemia microcítica: VCM baixo.

Principais causas: deficiência de ferro e talassemias.

Anemia normocítica: VCM normal.

Pode ocorrer em doença crônica, doença renal, sangramento agudo e hemólise.

Anemia macrocítica: VCM alto.

Principais causas: deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, alcoolismo, hepatopatia, hipotireoidismo e alguns medicamentos.

O reticulócito ajuda a avaliar a resposta da medula óssea. Reticulócitos elevados sugerem perda sanguínea ou hemólise; reticulócitos baixos sugerem baixa produção medular. A contagem de reticulócitos é considerada essencial na avaliação da anemia porque informa a resposta da medula óssea.

Para investigação de anemia ferropriva, devem ser solicitados ferritina, ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro/transferrina, saturação de transferrina, RDW e esfregaço periférico. O MSD Manual lista esses exames como parte da investigação diagnóstica da anemia ferropriva.

Na suspeita de anemia megaloblástica, solicitar vitamina B12 e folato.

Na suspeita de hemólise, solicitar bilirrubina indireta, LDH, haptoglobina, reticulócitos e Coombs direto, além de avaliar o esfregaço periférico.

Na suspeita de anemia por doença renal, avaliar creatinina e taxa de filtração glomerular.

- Achados laboratoriais clássicos

Ferropriva: hemoglobina baixa, VCM baixo, ferritina baixa, ferro sérico baixo, saturação de transferrina baixa, RDW aumentado.

Doença crônica/inflamatória: geralmente normocítica ou microcítica, ferro sérico baixo, ferritina normal ou alta.

Megaloblástica: VCM alto, B12 ou folato baixos, neutrófilos hipersegmentados no esfregaço.

Hemolítica: reticulócitos altos, LDH alto, bilirrubina indireta alta, haptoglobina baixa.

12 – Manifestações Clínicas das Arboviroses

- Sintomas principais

A dengue costuma cursar com febre alta de início súbito, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia intensa, artralgia, náuseas, vômitos, prostração e exantema. O Ministério da Saúde destaca febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náusea, moleza, dor nas articulações e manchas vermelhas no corpo como sintomas comuns.

A chikungunya se caracteriza por febre de início súbito e artralgia intensa, muitas vezes incapacitante, podendo acometer mãos, punhos, tornozelos e pés. A dor articular pode persistir por semanas ou meses, e o Ministério da Saúde classifica a doença em fase aguda, pós-aguda e crônica quando os sintomas persistem por mais de 90 dias.

A zika costuma ser mais branda, muitas vezes assintomática ou autolimitada, com febre baixa ou ausente, exantema maculopapular pruriginoso, conjuntivite não purulenta, artralgia leve, mialgia e cefaleia. O Ministério da Saúde descreve a maioria das infecções por ZIKV como assintomáticas ou semelhantes a dengue e chikungunya.

- Achados no exame físico

No exame físico, deve-se avaliar estado geral, sinais vitais, hidratação, perfusão periférica, pele, mucosas, articulações e sinais de sangramento.

Na dengue, podem aparecer febre, prostração, exantema, dor abdominal, hepatomegalia, sangramento de mucosas, petéquias, hipotensão, taquicardia, extremidades frias e enchimento capilar prolongado nos casos graves.

Na chikungunya, o achado mais marcante é dor articular intensa, frequentemente com edema articular, limitação funcional e dificuldade para deambular ou movimentar mãos e punhos.

Na zika, os achados mais típicos são exantema pruriginoso, hiperemia conjuntival não purulenta, febre baixa e artralgia leve.

- Sinais de alarme na dengue

Essa parte é muito cobrada.

Os sinais de alarme costumam aparecer com a queda da febre, geralmente entre o 3º e o 7º dia, e indicam risco de extravasamento plasmático, choque ou sangramento.

Pesquisar:

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Hipotensão postural ou lipotímia

Sangramento de mucosas

Sonolência ou irritabilidade

Hepatomegalia dolorosa

Acúmulo de líquidos, como ascite, derrame pleural ou derrame pericárdico

Aumento progressivo do hematócrito

Queda abrupta de plaquetas

Sinais de gravidade incluem choque, sangramento grave, dispneia, alteração de consciência, extremidades frias, pulso fino, hipotensão e má perfusão.

- Testes e avaliações práticas

A avaliação clínica deve incluir hidratação e perfusão periférica. Observar mucosas, sede, diurese, turgor, pressão arterial, frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar e extremidades frias.

Deve-se pesquisar sangramentos, como epistaxe, gengivorragia, petéquias, equimoses, hematêmese, melena e metrorragia.

A prova do laço pode ser solicitada quando há suspeita de dengue, principalmente para avaliar fragilidade capilar. Ela é feita insuflando o manguito no ponto médio entre a pressão sistólica e diastólica por 5 minutos em adultos; depois,

contam-se petéquias em uma área delimitada no antebraço. Prova positiva sugere fragilidade capilar, mas não confirma dengue isoladamente.

- Exames complementares

Na suspeita de dengue, solicitar hemograma com hematócrito e plaquetas. Achados comuns são leucopenia, plaquetopenia e hemoconcentração. A elevação do hematócrito sugere extravasamento plasmático.

Também podem ser solicitadas transaminases, função renal e eletrólitos, principalmente em casos moderados ou graves.

Para confirmação etiológica, podem ser usados:

NS1 ou RT-PCR: mais úteis nos primeiros dias de sintomas.

Sorologia IgM: mais útil após aproximadamente o 5º dia.

Na chikungunya e zika, também podem ser usados RT-PCR na fase aguda e sorologia conforme o tempo de doença, lembrando que pode haver reatividade cruzada entre flavivírus, especialmente dengue e zika.

--- Prova do laço

Técnica

Primeiro, aferir a pressão arterial do paciente.

Depois, calcular a pressão média:

$$PAS + PAD \div 2$$

Exemplo:

$$PA = 120 \times 80 \text{ mmHg}$$

$$120 + 80 = 200$$

$$200 \div 2 = 100 \text{ mmHg}$$

Então, insuflar o manguito até 100 mmHg e manter por:

5 minutos em adultos

3 minutos em crianças

- Como contar as petéquias

Após o tempo indicado:

1. Desinsufle o manguito.
2. Aguarde alguns instantes.
3. Observe o antebraço, geralmente na região abaixo da prega cubital.
4. Delimite um quadrado de 2,5 cm x 2,5 cm.
5. Conte as petéquias dentro dessa área.

- Resultado positivo

A prova é considerada positiva quando aparecem:

20 ou mais petéquias em adultos

10 ou mais petéquias em crianças

dentro do quadrado de 2,5 cm x 2,5 cm.

- Interpretação

Prova do laço positiva sugere fragilidade capilar, podendo ocorrer na dengue.

Mas atenção:

A prova do laço não confirma dengue sozinha e, se negativa, não exclui dengue.

Ela deve ser interpretada junto com quadro clínico, sinais de alarme, hemograma, plaquetas, hematócrito e exames específicos.

13 – Linfadenopatia

Hepatoesplenomegalia e Linfadenopatia no OSCE

- Hepatomegalia

Como examinar o fígado

O paciente deve estar em decúbito dorsal, com abdome exposto e relaxado.

A palpação é feita no quadrante inferior direito, avançando em direção ao rebordo costal direito enquanto o paciente inspira profundamente.

Durante a inspiração, o fígado desce, facilitando a palpação da borda hepática.

Também pode ser feita a percussão para estimar o tamanho hepático, avaliando a transição entre som pulmonar e maciez hepática.

O que descrever:

Ao palpar o fígado, deve-se descrever:

Tamanho: quantos centímetros abaixo do rebordo costal.

Borda: fina, romba ou irregular.

Superfície: lisa ou nodular.

Consistência: macia, firme ou endurecida.

Dor: doloroso ou indolor.

Pulsatilidade: presente ou ausente.

- Esplenomegalia

Como examinar o baço

O paciente deve estar em decúbito dorsal. O examinador palpa a partir da fossa ilíaca direita, seguindo em direção ao hipocôndrio esquerdo, porque o baço aumentado cresce em direção à fossa ilíaca direita.

Peça para o paciente inspirar profundamente durante a palpação.

Se não for palpável, pode-se posicionar o paciente em decúbito lateral direito, o que facilita a palpação do baço.

O que descrever

Ao palpar o baço, descrever:

Tamanho: grau de aumento.

Consistência: macio, firme ou endurecido.

Dor: doloroso ou indolor.

Borda: regular ou irregular.

Mobilidade com a respiração: geralmente desce à inspiração.

- Linfadenopatia

Como examinar os linfonodos

Deve-se palpar as principais cadeias linfonodais de forma sistemática:

Pré-auriculares

Retroauriculares

Occipitais

Submandibulares

Submentonianos

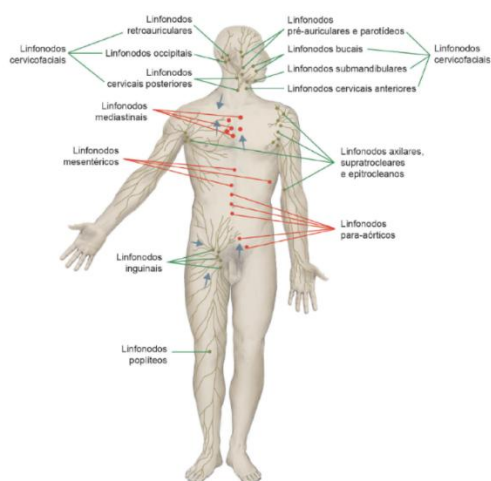
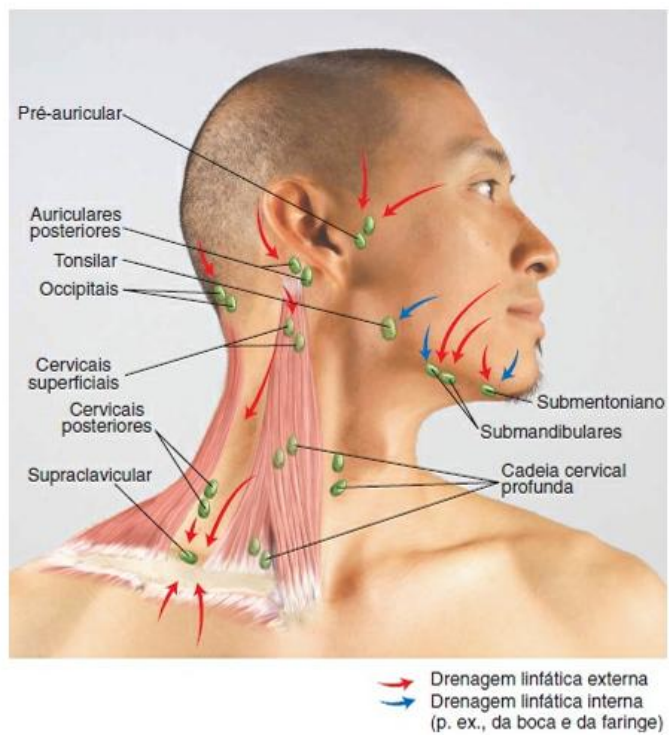
Cervicais anteriores e posteriores

Supraclaviculares

Axilares

Epitrocleares

Inguinais



A palpação deve ser feita com as polpas digitais, em movimentos circulares, comparando os dois lados.

O que descrever

Todo linfonodo palpável deve ser descrito quanto a:

Localização

Tamanho

Número

Dor
Consistência
Mobilidade
Aderência a planos profundos
Coalescência
Sinais flogísticos
Fistulização

- Interpretação dos linfonodos

Linfonodo sugestivo de processo infeccioso/inflamatório

Geralmente é:

Doloroso
Móvel
Fibroelástico
Com sinais flogísticos, às vezes
Relacionado a infecção próxima

Exemplo: linfonodo cervical doloroso em infecção de vias aéreas superiores.

Linfonodo suspeito de malignidade

Achados de alerta:

Indolor
Endurecido
Fixo ou aderido
Maior que 2 cm
Crescimento progressivo
Supraclavicular
Generalizado
Associado a febre, perda de peso e sudorese noturna

O linfonodo supraclavicular, especialmente à esquerda, é sempre preocupante e deve ser valorizado.

- Relação com linfoma

O Linfoma pode aparecer como caso de linfonodomegalia + sintomas B + hepatoesplenomegalia.

Os achados sugestivos são:

Linfadenopatia indolor e persistente
Linfonodos firmes ou endurecidos
Crescimento progressivo
Acometimento cervical, supraclavicular, axilar ou inguinal
Febre sem causa evidente
Sudorese noturna
Perda de peso
Prurido
Hepatoesplenomegalia

Frase para revisão:

- Exames complementares

A investigação depende da suspeita clínica, mas os exames iniciais podem incluir:

Hemograma completo com diferencial
Avalia anemia, leucocitose, leucopenia, linfocitose, blastos e plaquetas.

Esfregaço de sangue periférico
Útil se suspeita de leucemia, hemólise ou alterações hematológicas.

PCR e VHS

Avaliam inflamação, embora sejam inespecíficos.

Função hepática

AST, ALT, bilirrubinas, FA, GGT e albumina.

Sorologias conforme suspeita

HIV, EBV, CMV, hepatites, toxoplasmose.

Ultrassonografia de abdome

Confirma hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodos abdominais, sinais de hipertensão portal ou lesões hepáticas.

Radiografia ou TC de tórax

Pode mostrar linfonodomegalias mediastinais.

TC de pescoço, tórax, abdome e pelve

Ajuda a estadiar e localizar linfonodos profundos.

Biópsia excisional de linfonodo

É o exame mais importante quando há suspeita de linfoma.

14 – Discromias

O que observar na lesão

Ao examinar uma discromia, descreva:

Localização

Número de lesões

Tamanho

Formato

Cor

Bordas (bem ou mal delimitadas)

Superfície (lisa, descamativa, atrófica, infiltrada)

Sensibilidade (preservada ou reduzida)

Presença de pelos e sudorese

Sinais inflamatórios (calor, dor, edema, eritema)

- Principais tipos de discromia

- Hipocromia

É uma mancha mais clara que a pele normal, mas ainda com algum pigmento.

Exemplos:

Hanseníase

Pitiríase versicolor

Pitiríase alba

Hipocromia pós-inflamatória

- Acromia

É uma mancha sem pigmento, branca, geralmente bem delimitada.

Exemplo clássico:

Vitiligo

- Hiperchromia

É uma mancha mais escura que a pele normal.

Exemplos:

Melasma

Hiperpigmentação pós-inflamatória

Mancha café com leite

Lentigos

- Eritema

É uma mancha avermelhada por vasodilatação.

Característica importante:

Desaparece ou clareia à digitopressão.

Exemplos:

Dermatites, infecções, reações alérgicas.

- Púrpura

É uma mancha arroxeadada por extravasamento de sangue.

Característica importante:

Não desaparece à digitopressão.

Pode aparecer como petéquias, equimoses ou hematomas.

-----Hanseníase

A hanseníase deve ser suspeitada diante de mancha hipocrômica ou eritematosa com alteração de sensibilidade.

A lesão pode apresentar:

Mancha hipocrômica, eritematosa ou acastanhada

Bordas bem ou mal delimitadas

Redução ou perda da sensibilidade

Diminuição de pelos

Diminuição da sudorese

Pele seca

Espessamento de nervos periféricos

Fraqueza muscular ou deformidades, em casos avançados

---- Como testar sensibilidade na lesão.

- Sensibilidade térmica

* É a primeira a ser alterada na hanseníase.

Pode ser testada com tubos ou objetos frio/quente.

Pergunte ao paciente se sente frio ou quente.

- Sensibilidade dolorosa

Pode ser testada com objeto pontiagudo e rombo, alternando os estímulos.

Pergunte se sente “ponta” ou “toque”.

- Sensibilidade tátil

Pode ser testada com algodão, pincel ou monofilamento.

Peça para o paciente fechar os olhos e dizer quando sentir o toque.

Ordem prática:

Térmica → dolorosa → tátil

- Avaliação dos nervos na hanseníase

Além da mancha, deve-se avaliar nervos periféricos.

Principais nervos:

Ulnar — cotovelo

Mediano — punho

Radial — braço/antebraço

Fibular comum — cabeça da fíbula

Tibial posterior — atrás do maléolo medial

Auricular magno — região cervical

Facial e trigêmeo — face/olhos

Avaliar:

Espessamento

Dor à palpação

Alteração de sensibilidade

Fraqueza muscular

Diagnósticos diferenciais importantes

- Vitiligo

Manchas acrómicas, branco-leitosas, bem delimitadas.

Geralmente:

Sem alteração de sensibilidade

Sem descamação

Pode acometer face, mãos, áreas periorificiais e superfícies extensoras

Diferença para Hanseníase:

No vitiligo, a sensibilidade é preservada.

- Pitiríase versicolor

Micose superficial.

Lesões hipo ou hiperpigmentadas, geralmente em tronco, pescoço e ombros.

Pode ter:

Descamação fina

Múltiplas manchas

Sensibilidade preservada

Diferença para Hanseníase:

Na pitiríase versicolor, há descamação fina e sensibilidade preservada.

- Pitiríase alba

Mais comum em crianças e adolescentes.

Manchas hipocrômicas mal delimitadas, geralmente em face.

Pode ter descamação leve.

Sensibilidade preservada.

- Melasma

Manchas hiperpigmentadas acastanhadas, simétricas, principalmente em face.

Piora com sol.

Sensibilidade preservada.

- Hiperpigmentação pós-inflamatória

Mancha escura após inflamação, acne, dermatite, trauma ou queimadura.